



BLOC A

Emociones, autoestima y salud mental

Lo que sientes no es un problema técnico que haya que arreglar deprisa. Es información valiosa que conviene aprender a leer, a regular y, cuando pesa demasiado, a compartir con alguien que pueda ayudarte.

A QUÉ RESPONDE ESTA UNIDAD

El marco de la unidad



SABERES BÁSICOS

- Bloque A: emociones y su regulación.
- Bloque A: autoestima y salud mental propia y del entorno.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Reconocer y regular las emociones y cuidar la salud mental propia y del entorno.



§1

Qué son las emociones

*No son ruido que estorba al pensamiento:
son información con la que decides cada día*

Emoción, sentimiento, estado de ánimo



Emoción

Respuesta corta e intensa ligada a un disparador concreto. Dura segundos o minutos y llega con cambios físicos: el corazón se acelera, el estómago se cierra.

Sentimiento

La interpretación consciente de la emoción una vez procesada: del miedo a «tengo miedo de no aprobar». Dura más y se mezcla con tu historia personal.

Estado de ánimo

Tono emocional de fondo que dura horas o días, sin disparador único: la mezcla de muchas emociones recientes. Estar «de bajón» toda la semana es esto.



Las seis emociones primarias (Ekman, 1972)

DEL BIENESTAR A LA AMENAZA

- Alegría — algo importante para ti va bien
- Tristeza — pérdida; invita a parar y reconfigurar
- Miedo — amenaza percibida; prepara para huir o protegerse

DEL RECHAZO A LA NOVEDAD

- Asco — rechazo ante lo dañino, sucio o moralmente intolerable
- Ira — injusticia, límite traspasado u obstáculo a un objetivo
- Sorpresa — novedad inesperada; abre la atención a lo nuevo



Las secundarias: aprendidas y con juicio cultural

- Vergüenza — dolor por exponer en público algo que consideras un defecto
- Culpa — malestar por haber hecho algo que consideras incorrecto
- Orgullo — satisfacción por un logro que atribuyes a tu esfuerzo o identidad
- Envidia — malestar al comparar lo que otra persona tiene o consigue con lo tuyo
- Celos — miedo a perder algo o a alguien por la presencia de un tercero
- Gratitud — reconocimiento de algo bueno recibido de otra persona



§ 2

Cómo regular lo que sientes

Tres técnicas validadas por la psicología clínica. Regular no es controlar a la fuerza: es dar espacio sin ceder el mando



CONCEPTO CLAVE

Regular no es reprimir

La regulación emocional no es reprimir lo que sientes ni fingir que estás bien: es reconocer la emoción, nombrarla con precisión y elegir qué hacer con ella en lugar de reaccionar en automático. La psicología clínica —la terapia cognitivo-conductual, las terapias contextuales, el mindfulness de programas como MBSR— ha validado decenas de técnicas. Aquí van tres que cualquiera puede practicar.

Sentir miedo no se elige; cómo respondes al miedo, sí.



Daniel Kahneman (1934-2024)

Foto: nrkbeta, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

*Demostró que las emociones no son enemigas del pensamiento racional:
son parte de cómo decidimos. Su modelo vuelve en la Unidad 4.*

profedeconomia.es



Respiración 4-7-8

- 01 Siéntate con la espalda recta y los hombros relajados; si puedes, cierra los ojos.
- 02 Inspira por la nariz contando hasta 4: llena el abdomen, no solo el pecho.
- 03 Retén el aire contando hasta 7, sin tensar.
- 04 Espira por la boca contando hasta 8, despacio, con un sonido suave.
- 05 Repite el ciclo 4 veces; con práctica, 6 u 8. Alargar la espiración activa el nervio vago y baja el pulso en menos de un minuto.
- 06 Practícala dos veces al día en frío: entrenada funciona mucho mejor que improvisada en plena crisis.

Técnicas 2 y 3: para la rumiación y la autocrítica

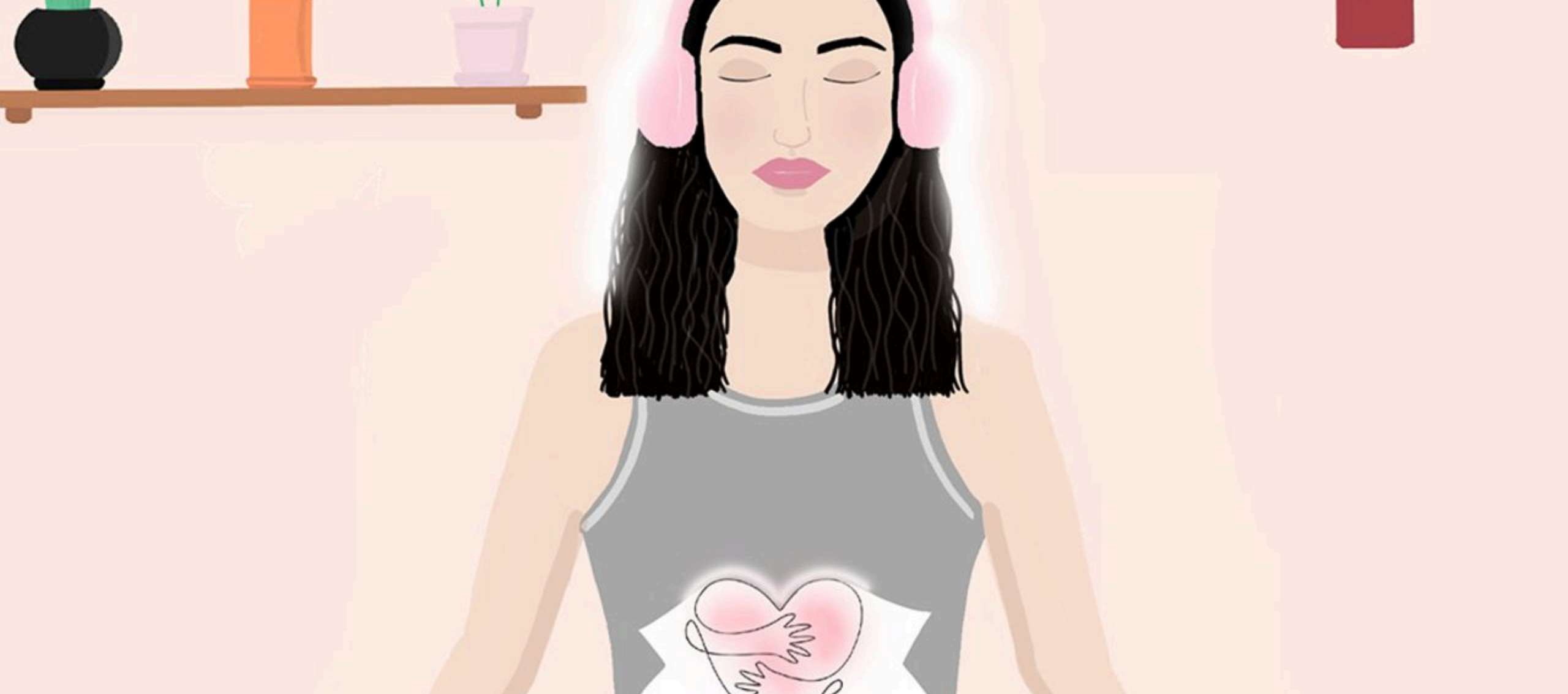


Reencuadre cognitivo

Entre estímulo y emoción hay un pensamiento automático (Beck). «No contesta: me ignora» da ansiedad; «estará sin batería» da calma. Elige la más completa, no la primera.

Distanciamiento lingüístico

Cambia los verbos de identidad por verbos de proceso: de «soy un desastre» a «estoy notando que me siento un desastre». Baja la intensidad sin negar la experiencia (Kross).



El mindfulness no es una moda New Age

Foto: Vaishali Dhiman, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Es una técnica clínicamente validada. Programas como el MBSR (Kabat-Zinn, 1979) se usan en hospitales y centros educativos.



§ 3

Ansiedad y frustración

*La emoción de la que más se habla hoy — y
cómo separar lo normal de lo que pide
consulta*

La ansiedad es miedo anticipatorio



NORMAL – Y ÚTIL

- El cuerpo se prepara para una amenaza que aún no ha llegado: examen, entrevista, conversación difícil
- En dosis adecuadas mejora el rendimiento: te mantiene alerta y te empuja a prepararte
- Sin ninguna ansiedad ante un examen importante, probablemente no estudiarías

POSIBLE TRASTORNO

- Se desproporciona respecto al estímulo
- Dura demasiado tiempo
- Aparece sin un disparador claro
- Si dura semanas o interfiere con tu vida diaria, consulta

1 de cada 7

ADOLESCENTES DE 10 A 19
AÑOS EN EL MUNDO

**Tiene un trastorno mental;
ansiedad y depresión, entre los
más frecuentes**

OMS (2024). En España, el malestar emocional adolescente ha crecido en la última década, sobre todo en las chicas. Y parte del aumento es buena noticia: hoy se pide ayuda por lo que antes se callaba.



SE ENTRENA

Frustración: la emoción del «no esperaba esto»

Aparece cuando un objetivo se bloquea o algo no sale como esperabas: la nota baja, la persona que te gusta no responde. Mezcla tristeza por la pérdida con ira por el obstáculo, y la adolescencia acumula «primeras veces» que aún no sabes manejar. Quien la tolera mal abandona a la primera dificultad, explota o se paraliza. Tolerarla es una habilidad: se entrena con las mismas técnicas de regulación de esta unidad.



§ 4

Autoestima, autoconcepto y redes

*Lo que piensas sobre ti condiciona lo que te
atreves a intentar y las relaciones que
aceptas*

El retrato, la nota y la creencia



Autoconcepto

La descripción que haces de ti mismo, cognitiva y casi neutral: «soy alto, se me da bien dibujar». Es tu retrato.

Autoestima

La valoración emocional de ese retrato: la nota que te pones. Puedes conocerte bien y aun así no aceptarte — y al revés.

Autoconfianza

La creencia de que puedes hacer algo concreto. Cabe mucha autoconfianza técnica con baja autoestima personal, y al revés.

Ni hundirse con cada crítica (débil) ni creerse por encima de todo (inflada): lo sano está en el centro

EXTREMO

EXTREMO

Autoestima débil

POR DEFECTO

Me hundo con
cualquier crítica

Creo que no valgo

Dejo que decidan
por mí

Autoestima sana

EQUILIBRIO

Reconozco lo que valgo
y lo que me falta

Encajo las críticas
sin hundirme

Pongo límites sin
pisar a nadie

Autoestima inflada

POR EXCESO

Nunca es culpa mía

Necesito tener
razón siempre

Piso a otros para
sentirme arriba



Lo sano está en el centro, no en los extremos



FESTINGER, 1954

La comparación social ahora es infinita

Comparamos para situarnos. Antes, con el grupo del barrio; ahora, con un feed infinito de gente seleccionada y retocada: tu día normal contra el mejor minuto de cien personas. Twenge y colaboradores (Acta Psychologica, 2022) reanalizaron grandes encuestas a adolescentes de EE. UU. y Reino Unido: más horas de redes se asocian con más síntomas depresivos, sobre todo en las chicas.

*No te creas la primera versión que te llegue:
ni la de los algoritmos, ni la de tu entorno
familiar, ni la tuya en un mal día.*



DISMORFIA DIGITAL

Retocarse antes de publicar

Filtros, retoque de cintura, alisado de piel: retocar una foto propia antes de publicarla es muy habitual entre adolescentes. Cuando la distancia entre el yo real y el yo digital crece, aparece la dismorfia digital. Hay cirujanos que atienden a adolescentes que piden parecerse a su propia foto filtrada, no a una persona famosa.

*Lo que ves en la pantalla está editado.
También lo que publicas tú.*



Pensamiento crítico y creatividad, aplicados a ti

PENSAMIENTO CRÍTICO: PREGUNTAR Y CONTRASTAR

- Cuestiona el pensamiento automático («no valgo para nada»)
- Busca evidencia en contra: «ayer terminé el proyecto», «la profesora me felicitó»
- Quédate con la interpretación más completa, no con la primera que se te ocurra

CREATIVIDAD: COMBINAR LO QUE YA EXISTE

- Imagina trayectorias vitales distintas de las que asumes por defecto
- Combina intereses aparentemente incompatibles: las carreras híbridas son cada vez más comunes
- Prueba experimentos vitales pequeños, sin compromiso eterno



La salud mental ya es tema deportivo

Simone Biles se retiró en Tokio 2021 para proteger su salud mental; Marín habla desde 2022 de la depresión que vivió tras lesiones graves.

Junta Informa, CC BY-SA 2.0



§ 5

Asertividad y pedir ayuda

Defender lo tuyo sin pisar al otro — y reconocer cuándo lo que sientes pide un profesional

Tres maneras de responder a un conflicto



	QUÉ HACES	QUÉ CONSIGUES
Pasividad	Callas lo que sientes para no molestar	Resentimiento; aprenden a pasar por encima de ti
Agresividad	Atacas: tono hostil, descalificaciones	Ganas la batalla y pierdes la relación
Asertividad	Expresas con claridad, sin atacar	El conflicto se aborda sin destruir el vínculo

La asertividad es la zona media: honesta con lo tuyo, respetuosa con el otro



La fórmula del «yo siento»

- 01 «Yo siento...» — nombra tu emoción (rabia, dolor, frustración). No empiezas atacando.
- 02 «...cuando tú...» — el hecho concreto, sin generalizar: «cuando no contestas», no «cuando eres egoísta».
- 03 «...porque...» — tu necesidad, no el juicio: «porque necesito saber que estamos bien».
- 04 «...me gustaría que...» — propón algo concreto: «avísame si vas a estar desconectado mucho rato».
- 05 Prácticala en frío sobre algo que ya ocurrió: en caliente cuesta más, con entrenamiento sale natural.



Tres señales que conviene tomar en serio

- Insomnio persistente: dormir mal, despertarte muchas veces o demasiado pronto, más de dos semanas seguidas.
- Aislamiento social: dejas de quedar, evitas lo que disfrutabas, estar con gente cuesta un esfuerzo enorme.
- Ideación suicida: pensamientos de hacerte daño o de no querer seguir. Una sola vez ya es motivo para hablar con alguien.

024

ATENCIÓN 24 HORAS,
GRATUITA Y CONFIDENCIAL

Línea de atención a la conducta suicida

Ministerio de Sanidad. Si hay peligro inmediato, 112. También: ANAR 900 20 20 10, Teléfono de la Esperanza 717 003 717, tu orientador y tu médico. «No estoy bien y no sé por qué» ya es un paso válido.



Antes de una exposición te repites «soy un desastre, no valgo para nada». ¿Qué técnica encaja mejor?

A Respiración 4-7-8

B Reencuadre cognitivo

C Distanciamiento lingüístico

D La fórmula del «yo siento»

Solución: C. Contra la autocrítica destructiva: «estoy notando que me siento un desastre» cambia identidad por proceso. La respiración es para crisis; el reencuadre, para rumiación.



Un compañero atribuye sus éxitos a sí mismo, los fracasos a los demás y vive cada crítica como un ataque. ¿Qué patrón de autoestima muestra?

A Sana

B Inflada

C Débil

D No es autoestima, es autoconfianza

Solución: B. Autoestima inflada o narcisista: aparentemente alta, en realidad frágil — cualquier pinchazo se vive como un ataque. La sana asume errores y críticas sin hundirse.



VUELVE AL CASO

Marta no tiene que «aguantar»

Su malestar dura más de dos semanas, interfiere con dormir y estudiar y ya la lleva a evitar situaciones: cumple las señales de alarma. La respuesta razonable no es «confiar más en sí misma», sino hablar con el orientador del centro, con el médico de cabecera o llamar a la Línea 024. La salud mental se gestiona, no se aguanta.

Pedir ayuda no es debilidad: es la decisión inteligente.



Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías nombrar las seis emociones primarias de Ekman y separar emoción, sentimiento y estado de ánimo.
- ☐ Sabrías aplicar tres técnicas de regulación emocional ante una situación estresante real.
- ☐ Sabrías distinguir una autoestima sana de una inflada o débil, y separarla de la autoconfianza.
- ☐ Sabrías explicar cómo las redes afectan al autoconcepto adolescente y qué es la dismorfia digital.
- ☐ Sabrías plantear un conflicto en formato asertivo: «yo siento... cuando tú... porque... me gustaría que...».

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.